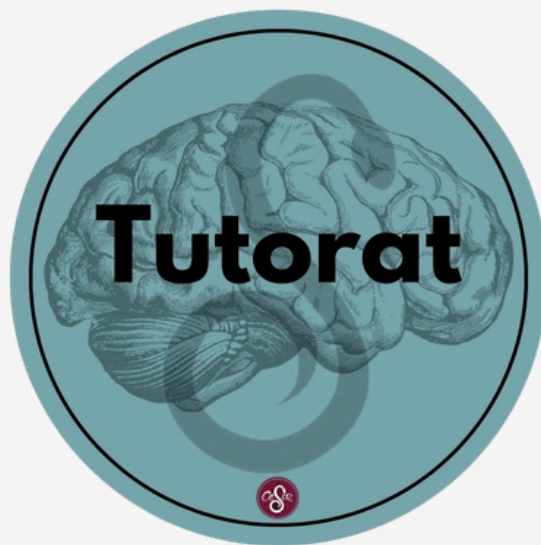
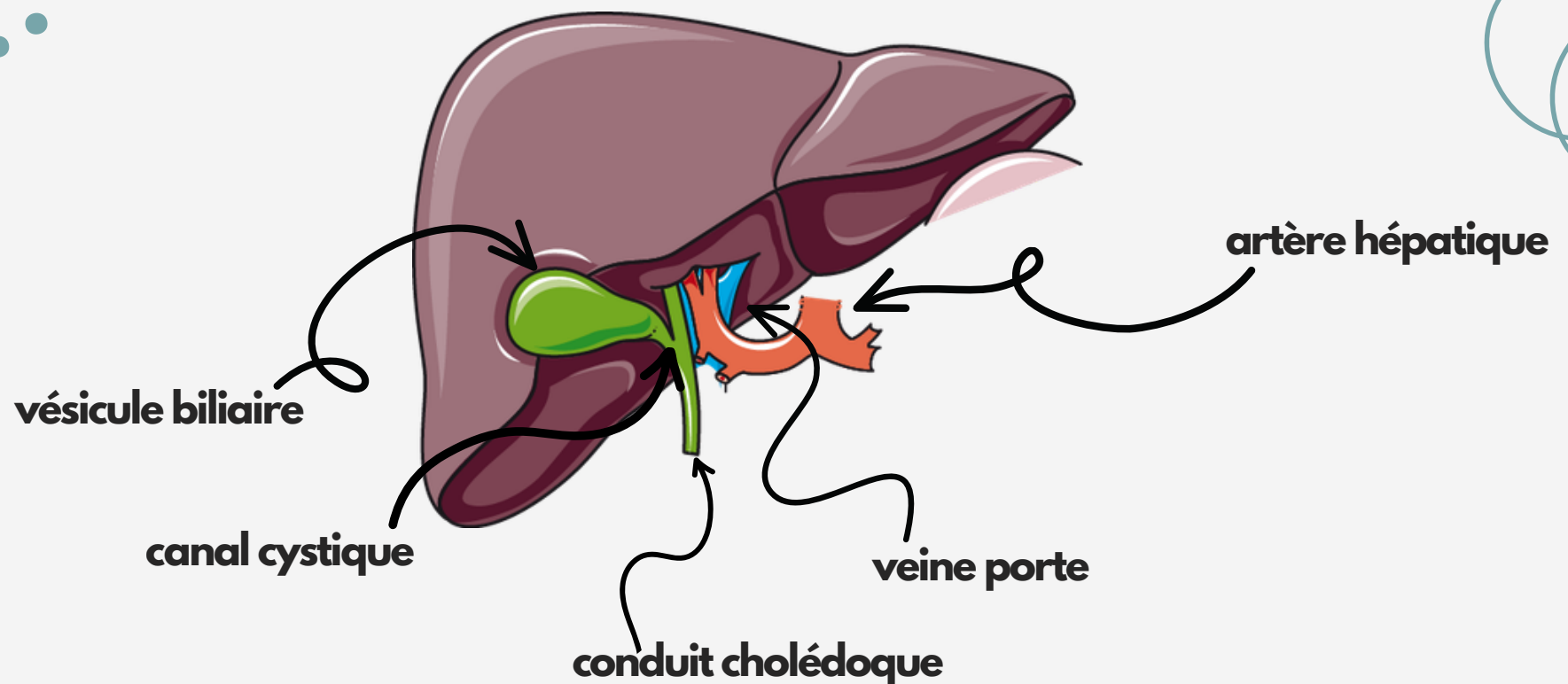


C'est quoi...

L'insuffisance hépatique



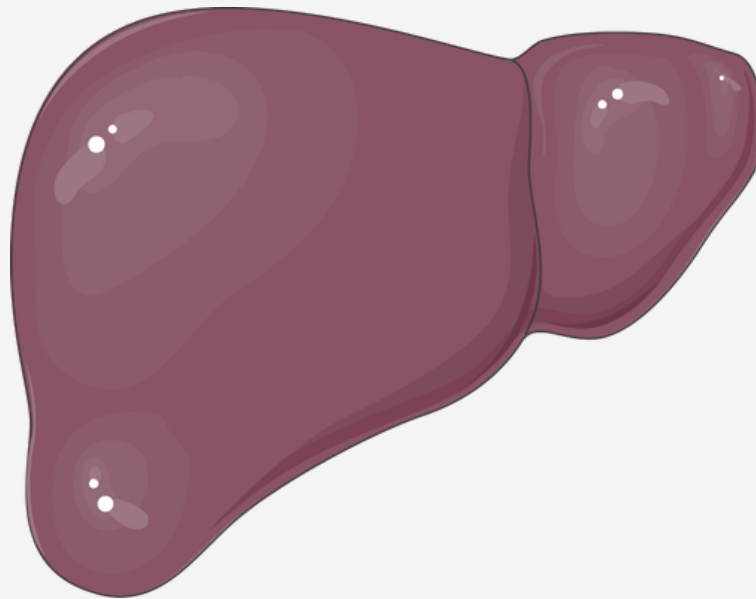
Rappel physiologique



le **foie** : organe situé dans l'hypocondre droit et qui assure trois fonctions vitales : une fonction d'épuration, une fonction de synthèse et une fonction de stockage

fonctions hépatiques : stockage et répartition du glucose, synthèse de l'albumine, globines, des facteurs de coagulation, épuration des substances toxiques comme l'alcool

Insuffisance hépatique



L'**insuffisance hépatique** est induite par une altération des fonctions du foie due à la **destruction / nécrose hépatocytaire**

Cette insuffisance entraîne des troubles du métabolisme des **glucides** et des **lipides**, une diminution de la synthèse des **protéines sanguines** ainsi qu'un défaut d'élimination des **toxines** comme l'**ammoniaque** ce qui peut entraîner des troubles neurologiques comme une encéphalopathie hépatique

À terme cette pathologie devient **chronique** et peut entraîner une cirrhose hépatique



Etiologie

- **Hépatites virales**

Hépatite A (oro-fécale) / Hépatite B (sexuelle, parentérale, materno-foétale)

Hépatite E (oro-fécale, viande porc)

- **Comportementale**

Intoxication due à la consommation excessive d'alcool, utilisation de substances illicites

- **Médicamenteuse / toxique**

Paracétamol (toxique à partir de 150mg/kg) / champignons

- **Auto-immune**

Anticorps dirigés contre les hépatocytes

- **Maladie de Wilson**

Accumulation hépatique de cuivre

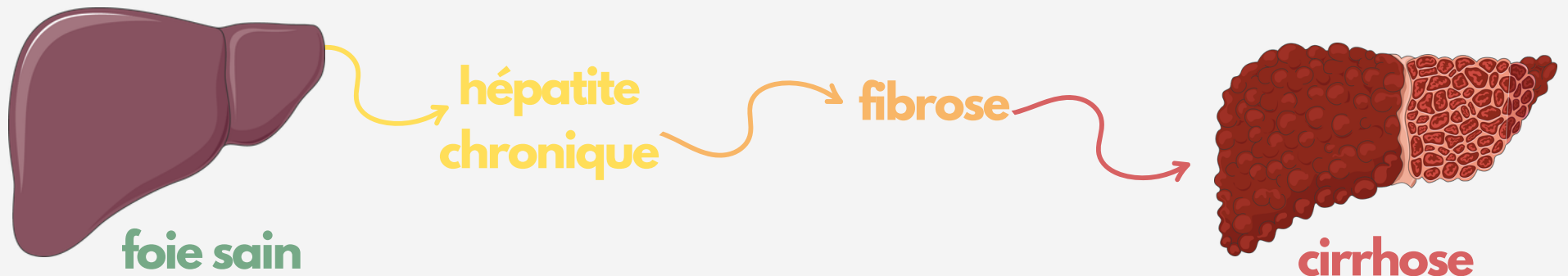
- **Foie de choc**

Ischémie hépatique



Cirrhose

La cirrhose est une évolution prolongée d'un processus de **destruction** + de **reconstruction** hépatocytaire



Cette possible évolution est due à des agressions répétées des hépatocytes induite par certains agents comme l'**alcool**, un syndrome **métabolique** (alimentation), **hépatite** B/C/auto-immune/etc...

Insuffisance hépatocellulaire : manifestations cliniques et biologiques

- **Cliniques** : Ictère / angiomes stellaires / hippocratisme digital / érythrose palmaire
- **Biologique** : Diminution du TP, Facteur V, Albumine / Cholestérol et augmentation de la bilirubine



Symptômes cirrhose

Hypertension portale : hypertension due à un obstacle à l'écoulement du sang dans la veine porte a cause du foie fibreux, ce qui crée donc une augmentation de la pression

Hypogonadisme :  aménorrhée, stérilité
 impuissance, atrophie testiculaire, stérilité

Ascite / Œdème : augmentation du périmètre abd, douleur, dyspnée / œdème des membres inférieurs

Encéphalopathie hépatique : complications neuro de la cirrhose, induit une confusion, désorientation, troubles de l'humeur et du comportement flapping tremor

Hémorragie digestive : ruptures de varices oesophagiennes ou gastriques, extériorisation du sang digéré (selles noires + malodorantes = méléna)
hypotension, tachycardie



Traitement cirrhose

Pour **traiter** la cirrhose il faut en premier lieu **étudier** et **soigner** la cause :
sevrage éthylique / faire un point sur l'alimentation du patient / traiter
l'hépatite virale / etc

Ensuite il va falloir traiter les complications :

- Traitement de l'ascite et des œdèmes avec des diurétiques (furosémide),
une surveillance du poids
- Ponction d'ascite (**9L MAX**) avec une perfusion d'**albumine 20%** pendant
la ponction pour éviter une dysfonction circulatoire
si infection de l'ascite → TTT sous **antibiotiques** pendant 7j + albumine
- Traitement de l'ascite réfractaire : si intolérance ou inefficacité des
diurétiques, installation d'un **TIPS** (shunt intra hépatique)
- Prise en charge en centre d'**addictologie** pour un **sevrage** du patient

